

Démocratie et Santé - Martin Hirsch

Hopital est souvent le premier employeur de la ville. C'est le cas de l'AP-HP. Ce sont donc des grandes communautés humaines qui comportent plusieurs professions :

- Médecins qui ont un statut particulier à l'hôpital public : praticien des hopitaux publics. C'est un corps particulier comme il y en a pour les douanes etc. Il y a aussi des contractuels même si c'est minoritaire. Les carrières se commencent par une période contractuelle. C'est le corps national des praticiens hospitaliers. Les règles qui les régissent sont fixes par un texte réglementaire nationale, pas par l'hôpital (rémunération, avancement, etc.), c'est un élément important qu'on verra par la suite.
- Autre personnel : infirmiers, masseurs kiné, manip radio, aides soignantes, personnels administratifs, techniques. Leur dénomination officielle c'est PNM pour personnel non médical. Cette dénomination tend à montrer qu'il y a vraiment deux mondes dans l'hôpital, les gens qui soignent et les autres. C'est pas juste symbolique. C'est très fort comme division.
- Sous ensemble paramédical
- Un autre ensemble genre comme dans les autres entreprises, informaticiens etc.
- Directeur d'hôpital : fonction d'encadrement supérieur dans un cadre hospitalier. Pas uniquement directeur d'hôpital au sens strict => il y a 250 directeurs d'hôpital. C'est un corps qui se mélange peu avec les autres. Endogamie importante que l'on ne retrouve pas dans les autres pays.

C'est pas l'ensemble de la communauté hospitalière. On peut rajouter les patients bien sûr.

Corps : maître de conférences praticien hospitalier, professeur des universités praticien hospitalier.

Y'a pas que des médecins dans un hôpital.

Hopitaux publics : généraux et universitaires (environ 2/3 de la capacité)

Hopitaux privés à but non lucratif : Curie et quasi tous les centres anti cancéreux. Hespici

hopitaux à but lucratif : on les appelle des cliniques (les deux ensemble 1/3)

Dans les hopitaux généraux il y a un cas particulier des hopitaux universitaires (une trentaine).

Le plus gros c'est l'AP-HP c'est 10% de la capacité hospitalière

LA capacité hospitalière avant on considérait que c'était le nombre de lits, mais avec l'avènement de l'ambulatoire

Avant on considérait la puissance d'un chef de service en fonction de son nombre de lits dans son service.

Pitié Salpêtrière, plus grand hôpital site unique de France (il pense) et les grands hôpitaux de l'AP, c'est de l'ordre de 800 à 1000 lits. Dans les villes moyennes c'est entre 100 et 200 lits.

Il n'y a que dans les hôpitaux universitaires que l'on fait des essais cliniques. Donc s'il y a un nouveau traitement, il y a une chance qu'on l'obtienne dans l'HU, pas dans les hôpitaux généraux.

Pareil pour l'équipement, peut-être qu'il y a des chances que l'IRM soit avec 4 Tesla que 1 Tesla.

Structure de l'hôpital

Avant il y avait le service hospitalier, le service de radiologie, de médecine interne, de ... avec un chef de service.

Ensuite, il y avait l'hôpital.

Les hôpitaux sont des établissements publics avec un conseil d'administration. Depuis 15 ou 20 ans, la structuration a un peu changé. On a toujours des services mais qui sont au sein d'une structure dont doit se doter l'hôpital qui s'appelle un pôle qui regroupe plusieurs services.

Pourquoi on doit faire un pôle ?

=> Parce qu'on a considéré que de morceller autant les services, ça créait trop de "baronnies" donc il fallait les casser pour que les services travaillent ensemble et que ce soit plus efficace. Ça c'est le premier changement qui était traumatique. Pourquoi il était traumatique ? Parce qu'on a considéré que le service n'avait plus d'existence juridique obligatoire. Qu'un pôle est composé d'unités fonctionnelles qui est le nom techno des services.

Dans la mythologie, les séries, la manière dont se présentent les patrons de médecine, les notions de service et de chef de service restent extrêmement importantes pour le corps de médical. Alors que chef de "pôle" ça ressemble à rien. "chef de service" ça a des siècles d'existence.

Chef de service c'est prestigieux. C'est associé à une pratique médicale bien identifiée.

Il y a des différences entre les hôpitaux. Ces différences font des différences dans les services proposés. Par exemple l'hôpital de Dieppe ne peut pas faire de greffe de cœur s'il n'y a pas un nombre de services associés à ça. La réputation d'un hôpital peut être réputée dans un certain service, ou dans une chirurgie particulière.

Il y a effectivement toute une discussion et des tentatives non totalement abouties pour essayer de graduer l'organisation hospitalière. Il y a des hôpitaux dits de premier recours, deuxième recours et troisième recours.

Y'a des pays dans lesquels c'est extrêmement structuré. En France ce n'est pas le cas. On peut prendre rdv en neurologie à la pitié salpêtrière qui a la réputation d'être la meilleure d'Europe là-dedans.

La question s'est posée quand on a introduit Doctolib à l'hôpital. C'était impossible de prendre rdv avec un appel, ou un mail donc les gens se déplaçaient de super loin juste pour prendre un rdv à l'accueil directement. C'est pour cela qu'il a introduit Doctolib.

Il y avait des problèmes au début car des patients réservaient des créneaux pour des hôpitaux extrêmement spécialisés, dans le cancer par exemple pour un enfant qui a 39 de fièvre.

Qu'est-ce qu'un bon service ou un bon hôpital ?

Il y a 30 ans, il n'y avait aucun outil permettant de le faire.

Les hôpitaux détestaient qu'on les évalue sous l'angle que la médecine est un art et que personne ne peut dire s'ils sont bons ou pas et que les services sont intrinsèquement différents entre différents hôpitaux.

Secrétaire particulière qui conseillait où aller quand un ministre demandait où aller. "ah ben pour le foie c'est là-bas qu'il faut aller"

Il y a eu le premier classement des hôpitaux par l'Express.

Le prof s'est dit que c'était quand même con que ce soient les "connards de l'Express" qui se permettent de faire un classement des hôpitaux et pas directement la puissance publique hospitalière qui le fait elle-même.

Ensuite ils ont fait un système d'accréditation, pas avec une note mais avec une grille d'évaluation sophistiquée. Est-ce que c'est parfait pour autant ? Non.

Il y avait un service à Cochin ou ailleurs qui avait été noté C. Le prof a appelé Agnès Buzin et a dit que quand même la note est pas folle. Et la ministre de répondre que c'est mérité. Et le prof a dit que s'il avait un problème, il irait quand même + à l'hôpital Cochin qui a été noté C plutôt qu'un autre qui a été noté A.

On est dans un univers dans lequel l'objectivation n'est pas si simple que ça.

Les enjeux de pouvoir à l'hôpital

Pourquoi il y a des enjeux de pouvoir à l'hôpital ?

Il y a une particularité à l'hôpital que l'on ne retrouvera pas vraiment ailleurs sauf éventuellement à Air France :

- les fonctions les plus nobles sont détenues par les médecins. Et quand on arrive par exemple infirmier, on sait qu'on ne pourra pas devenir médecin. Ce qui est rarement le cas, on peut arriver en bas d'une entreprise et devenir patron (bon ceci dit ça relève du conte

maintenant). Tout cela crée un enjeu de pouvoir et de domination qui est très particulier à l'univers hospitalier d'autant plus accentué au cours des dernières décennies que ça coïncide avec deux autres choses :

- le genre : 80% des aides soignants sont des femmes, pareil pour infirmière, avant 80% de médecin à l'époque. Maintenant il y a une majorité de médecins femmes. Et à l'AP-HP ils étaient à 30% de chef de service femmes, mais ils étaient partis de vraiment très bas. Anecdote du prof : les infirmières étaient en sous vêtement sous leur blouse alors que les médecins ne l'étaient pas. C'était une forme de domination implicite de catégorie et de genre. Et donc quand une femme infirmière passait devant une lumière forte, on voyait ses formes. Maintenant il y a des pyjamas et ça aide grandement à lever cette domination. Tout cela va en fait très loin. Dans la cantine de l'hôpital, le médecin n'ira pas manger avec les infirmiers, c'est extrêmement rare.
- l'origine sociale :

•

La possibilité de progrès social dans l'échelon a été diminuée au fil du temps. Pourquoi ? Parce que l'hôpital doit payer en fait l'équivalent de 6 salaires si une personne veut devenir infirmière par promotion alors qu'elle était aide soignante. Payer le salaire de la personne qui reprend une formation de 3 ans, et payer le remplaçant donc $3+3 = 6$ salaires.

Il y a eu des grèves très spectaculaires, canons à eau contre les infirmières. Elles sont planté une tente en face du ministère de la santé. Elles ont obtenu d'intégrer la catégorie A de la fonction publique. Et elles ont obtenu d'avoir une sorte d'autonomie dans leur gestion avec une direction paramédicale dans l'hôpital. Donc une sorte de hiérarchie particulière pour les personnels paramédicaux.

Professions médicales : dentistes, sages-femmes, pharmaciens

Professions paramédicales : ce qui les différencie ce sont les droits de prescription. MAis c'est en train de changer avec les infirmières de pratique avancée.

Etudes de sage-femmes c'est 5 ans actuellement, et elles voudraient être en études de 6 ans pour des idées de reconnaissances statutaires alors que techniquement c'est pas trop le cas. En Australie c'est 3 ans les sages femmes la formation.

Dans un service il y a des médecins et des paramédicaux.

Chef de service, en dessous il y a des chefs d'unité.

Pour les paramédicaux, il y a les cadres qui sont au dessous. Il y a une école des cadres et on ressort dans un corps différent qui est le corps des cadres. Avant on appelait ça surveillante ou bonne soeur en chef.

Ce qu'ont obtenu les infirmiers et les infirmières, c'est que ce soit la direction des soins qui choisisse le cadre et pas les médecins. Ceci a fait de nombreux malaises : avant, le médecin pouvait choisir son équipe, maintenant ce n'est plus le cas. Tout cela a complexifié la gestion de

la ressource humaine dans l'hôpital. LE prof indique qu'il ne pense pas que l'état précédent était préférable mais cette organisation se retourne contre les personnes qu'elle était censée servir.

En France on a fait ce choix de considérer que ce sont des administratifs qui dirigent l'hôpital. C'est un choix qu'on a fait dans très peu de pays. L'idée derrière c'est de laisser l'administratif à quelqu'un d'autre et que le médecin puisse vraiment se focaliser sur la stratégie de soins. Et aussi qu'on peut être un excellent médecin et un très mauvais gestionnaire. Et aussi de se dire que le médecin n'aura pas la disposition d'esprit pour bien gérer car si c'est un cancérologue, il voudra peut-être trop privilégier le service de cancérologie. Alors que le directement d'hôpital est considéré comme plus neutre de ce côté.

L'hôpital est un lieu de tensions. La tension première c'est le budget. Pour chaque malade il devrait y avoir les meilleurs équipements, un temps infini pour y consacrer car c'est trop important de pouvoir soigner les gens. Personne ne se dira "je suis ok pour avoir des anciens traitements, moins de personnel, un équipement moins moderne". **Le besoin est illimité et le budget est limité.**

Le plus cher traitement à 2 million d'euros, quelques autres à une centaine de milliers d'euros. LE prof prend l'exemple d'un traitement par irradiation qui est extrêmement précis au millimètre ou dixième de millimètre près. MAis ça coûte 10 millions d'euros. Donc ça on peut pas le mettre partout (appareil stéréotaxique)

Commission médicale d'établissement : représentant des médecins qui sont obligatoirement consultés sur les grands choix. Il y a maintenant une instance de dialogue social qui s'appelle le CSE. Il y a forcément une représentation des personnels. Il y a deux structures comme ça, une pour les personnels médicaux et une pour les autres.

Autant on passe parfois outre l'avis du CSE, autant on ne passe jamais outre la commission du corps médical.

Il y a une asymétrie dans l'influence au niveau de l'hôpital.

Pendant le COVID, il s'est passé un truc intéressant de ce côté : tout cela a été aboli car on était en organisation sauve qui peut. Juste après en sortant, le prof a proposé qu'on casse les codes et que pour la première fois, on fasse une organisation tripartite et qu'on négocie le projet social là. Donc une négociation unifiée, que l'on discute en même temps les organisations de travail parce que autre sujet majeur : les organisations de travail sont des enjeux de pouvoir de manière extrêmement importante à deux modalités :

- répartition des effectifs : pénurie de soignants crée manque de budget. Le prof est allé faire l'introduction de l'appareil stéréotaxique dans un hôpital. Il revient plus tard et les gens disent qu'il fonctionne bien le matin mais pas l'après-midi. Car personne ne veut venir travailler le midi comme manipulateur radio.

- horaires de travail : deux grands horaires à l'hôpital : après midi qui va de 13h à 19h et le matin de .. à On paye les mêmes salaires aux deux donc c'est plus difficile de faire venir les gens l'après-midi.

LE prof pour régler le problème des manipulateurs est rentré en zone grise : pas possibilité d'augmenter les salaires car régi par une réglementation. Donc il a créé une prime d'encadrement qui n'est pas régie réglementairement de 300€ et il leur donnait leur vendredi en congé.

Il y a 20 ans les gens se battaient pour avoir des nuits, maintenant c'est l'inverse. 240€ la garde 12h de samedi à dimanche donc les médecins disaient qu'il préféraient faire de la coiffure.

SEGUR : demandes non accédées (garde + nuit) donc il y a eu des grèves 6 mois 1 an plus tard. 500 millions d'euros ont été alloués pour régler cela.

L'impuissance est un terrain de jeu pour les enjeux de pouvoir. Pourquoi peu de capacités de pouvoir ?

- salaires : fixés au niveau national statutairement

Quand le cadre est trop rigide, il y a des effets de fuite et des effets d'explosion ou d'implosion (désertion, pénurie, manque de personnels)

Paradoxe de l'hôpital : premier employeur mais très peu d'éléments sur les affectations, sur les salaires, organisation (unités fonctionnelles, commission, services dont on ne pouvait pas s'affranchir jusqu'à récemment avant la loi Ritz (pas sûr de l'orthographe) mais avec des conditions de verrou qui sont tellement difficiles que dans la pratique ça se fait pas souvent.

Il y a donc un sentiment que comme ce n'est pas possible de faire une réponse locale et liée à ces problématiques, on est lié à ces contraintes.

à l'AP-HP ils ont un parc immobilier de 7000 logements. Sur les 100k personnes il y a 30k infirmières, 25k aides soignantes. Compte tenu du turn over dans le parc hospitalier, on peut affecter 300 ou 350 personnes par an. La demande était 15 fois plus. LE prof a réussi à passer à 400 en construisant d'autres logements mais c'est beaucoup trop faible.

à l'AP il y a 250 directeurs d'hôpital, il y a donc 250 logements pour eux. (LE prof trouve ça aberrant). Avant ça se comprenait car il fallait que le directeur puisse verser le premier seau d'eau s'il venait à être en feu. Et aussi, les logements de directeur d'hôpital ont été pris par les unités de recherche INSERM etc.

LE prof a dit qu'il avait réussi à trouver un truc dans le droit pour faire du troc et échanger ses logements dans plein paris de 180m² par directeur d'hôpital contre 300 logements dans la petite couronne de 60-70m² pour les infirmières.

Délégation de pouvoir vers les pôles qui a causé beaucoup de problème :

Médecins : on a pas tant envie que cela de se retrouver en position d'arbitre face à nos confrères (il mérite pas d'avoir 5 infirmières de plus) et aussi de décider les travaux peinture alors qu'on a fait 10 ans d'études et une HDR etc.

Les médecins voudraient avoir le pouvoir de dire oui sans avoir le pouvoir de dire non.

Quand le prof est arrivé à l'AP, il s'est dit je vais nommer en numéro 2 un médecin. Les directeurs d'hôpitaux et les médecins s'y sont opposés. "Qui êtes vous M. Hirsch pour décider de qui va être votre numéro 2 ?" donc il n'a pas osé.

Mais après le COVID, il est revenu à la charge et c'était compliqué pour eux de dire non. Il a nommé une femme chef de pôle anesthésie qui s'était beaucoup impliquée. Elle est venue directrice adjointe de l'AP-HP (dirige les stocks etc.).

Son rapport d'étonnement était de dire à quel point le prof était sympa avec les médecins. Le prof a ensuite compris pourquoi les médecins refusaient tant que ce soit un collègue à eux.

Le prof pense que l'hôpital doit être dirigé par un collectif mixte, DH, chef de pôle, infirmière en chef etc. avec une instance de décision qui décide de qui dirige l'hôpital et ça change de temps en temps comme ça peut se faire dans d'autres pays.

Pendant le COVID, le prof faisait des réunions de crise. Et là il a introduit les patients. Dans les grandes discussions qu'ils avaient tous les soirs, il y avait donc des représentants des patients. Les représentants des patients disaient des choses pertinentes : est-ce qu'on peut pas prendre en compte l'intérêt d'autres catégories de patients.

Dans cette instance qui était la plus sensible de toutes en termes de décisions, le corps étranger était là (patient). En sortant du COVID il a dit qu'il n'y avait aucune raison de pas continuer à introduire des représentants de patient dans les directoires.

Cela a permis d'introduire en 2021 les représentants des patients dans le directoire dans la loi. Cela permet de prendre les patients comme partie prenante à part entière de l'hôpital.

Comment les représentants des patients sont choisis ?

Ils sont choisis par des associations de patients (ils ont le label association de patients) et ces associations se mettent d'accord pour désigner en leur sein quelques personnes. Dans les 38 hôpitaux ils ont genre 150 représentants de patients.

Et pour désigner les 2 dans la direction. Il fait un appel de candidature + audition par le prof directement pour ensuite les choisir (donc entretien un peu comme dans un travail)

Sur la place même du patient dans un enjeu démocratie, c'est au centre de la décision que c'est fondamental que le patient soit là.

Quand un patient entre dans l'enceinte de l'hôpital, il devient officiellement sous la responsabilité de l'hôpital